

Profilaktyka *nawrotów paniki*

Pojedynczy atak po miesiącach wolności = *potknięcie*, nie nawrót. Plan „jeśli-to” zmniejsza ryzyko pełnego nawrotu o połowę.

CZAS: 30-45 min (sesja kończąca) Plus 1-2 sesje odświeżające/rok

ŹRÓDŁO: Marlatt (1985); White i wsp. (2013, JCCP); Barlow (2000, JAMA)

JAK UŻYWAĆ

Na ostatniej sesji aktywnej terapii wypełnij **cały arkusz** z terapeutą. Wpisz konkretne sytuacje wysokiego ryzyka, sygnały prodromalne, plan „jeśli-to” dla każdego sygnału, daty sesji odświeżających. Trzymaj arkusz w widocznym miejscu (lodówka, notatka w telefonie) i wracaj do niego co miesiąc — pytanie kontrolne: „czy unikam czegoś nowego w ostatnim miesiącu?”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Bez planu nawroty sięgają **30-50%** w 2 lata; z zapisanym planem spadają o połowę (White i wsp., 2013). Marlatt (1985) opisał *efekt naruszenia abstynencji*: pierwszy atak po remisie wyzwala katastrofę „wszystko wróciło, terapia nie zadziałała”. Przekonanie samo przyspiesza nawrót przez powrót do unikania i zachowań zabezpieczających. Craske i Barlow (2007): pacjenci **bez** zapisanego planu mają **2x wyższe ryzyko** nawrotu niż z planem.

01 Potknięcie ≠ nawrót — dystynkcja kluczowa

Pojedynczy atak po miesiącach wolności **nie** znaczy, że terapia nie zadziałała. To *potknięcie* (ang. *lapse*) — naturalna, oczekiwana fluktuacja, która sama mija. **Nawrót** (ang. *relapse*) to powrót *całego wzorca*: unikanie, zachowania zabezpieczające, katastroficzne myśli. Mylenie tych dwóch pojęć jest najczęstszą przyczyną prawdziwego nawrotu.

POTKNIĘCIE (LAPSE)

Co to: pojedynczy atak, krótka eskalacja lęku.

Czas: 1-3 dni, samoograniczające.

Co robić: wracam do dziennika, sprawdzam, czy nie wróciły zachowania zabezpieczające. Jedna sesja przypominająca w razie potrzeby.

Komunikat dla siebie: „To znany problem, mam narzędzia.”

NAWRÓT (RELAPSE)

Co to: 3+ tyg. powrotu wzorca — unikanie, zachowania zabezpieczające, katastroficzne myśli przewlekłe.

Czas: kilka tyg., narasta.

Co robić: powrót do terapii — 2-4 sesje, czasem pełen cykl.

Komunikat dla siebie: „Czas po pomoc — i ona zadziała.”

02 Sygnały prodromalne — czego szukać w pierwszych tygodniach

„Pełzające unikanie” to największe zagrożenie. Drobne, niezauważalne zmiany: „autobus 149 zamiast 144 — bo mniej ludzi”, „wychodzę 10 min wcześniej, żeby nie stać w tłumie”. Po 3 mies. jest ich 20 i nagle przestajesz latać samolotem. Każdy z poniższych sygnałów warto monitorować.

Lek wraca do torebki „na wszelki wypadek” — nawet jeśli nie używasz.

Wybierasz „bezpieczniejsze” trasy, godziny, miejsca bez świadomej decyzji.

Lęk antycypacyjny przed wyjściami, planowaniem, „a co jeśli”.

Sprawdzasz puls 2x w tygodniu lub częściej.

Powraca skanowanie ciała — „nasłuchiwanie serca”, monitorowanie oddechu.

Powrót katastroficznej narracji — „a może to jednak coś poważniejszego”.

Plan musi być **konkretny i zapisany**, nie ogólny. Każdy sygnał ma przypisaną akcję „jeśli-to” z datami, kryteriami i nazwiskami terapeutów rezerwowych.

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA Z TERAPII

— co zmieniło się najmocniej? Własnymi słowami.

MOJE SYTUACJE WYSOKIEGO RYZYKA

— stres, choroba, brak snu, zmiana pracy, rocznice trudnych wydarzeń

MOJE SYGNAŁY PRODRAMALNE

— jakie konkretne zachowania świadczą, że się cofam?

PLAN „JEŚLI-TO”

— np. „Jeśli 2× w tyg. wracam do sprawdzania tętna → wracam do ekspozycji interoceptywnej 5×/tydz.”

DATY SESJI ODŚWIEŻAJĄCYCH

— 1–2 w pierwszym roku

KRYTERIUM POWROTU DO TERAPII

— „jeśli przez 3 tyg. plan nie pomaga, wracam”

SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA

— terapeuta + zastępczy + osoba bliska wtajemniczona w plan

=== CALLOUT ===

Klucz: w planie zapisz **pytanie kontrolne raz w miesiącu**: „Czy unikam czegoś nowego w ostatnim miesiącu? Czy wróciły zachowania zabezpieczające?”. Marlatt (1985): świadoma dystynkcja potknięcie/nawrót obala katastroficzną narrację „terapia nie zadziałała”. *Sesje odświeżające* (ang. *booster sessions*) 1–2× co 3–6 mies. przez pierwszy rok obniżają nawroty o ~50% (White i wsp., 2013). Nie czekaj na kryzys — wpisz daty od razu.